

● Status: ONLINE

Playbook Clínico: Doenças Exantemáticas

Guia de Simulação, Diagnóstico Diferencial e Manejo
Prático

[Público]: 6º Semestre (Medicina/Enfermagem)

[Módulo]: Laboratório de Simulação

[Versão]: Protocolo Clínico Atualizado

A Missão Clínica

Competências-alvo para o laboratório de simulação de exantemas.



Investigar & Diagnosticar

- Reconhecer critérios definidores de doenças exantemáticas.
- Diferenciar patologias através de exame físico direcionado (textura, padrão de espalhamento).



Intervir & Manejar

- Solicitar exames laboratoriais baseados em protocolos.
- Indicar tratamento adequado (antibioticoterapia vs. suporte).
- Definir critérios rigorosos de internação vs. seguimento ambulatorial.



Comunicar & Documentar

- Manter comunicação clara com a equipe sob pressão.
- Orientar familiares sobre evolução e prevenção.
- Registrar todas as condutas com precisão no prontuário.

Cronograma da Simulação (1h40)



O Funil de Decisão Clínica

1º Momento - O Diagnóstico

Estabelecer hipóteses diagnósticas principais e identificar os prováveis agentes etiológicos.

2º Momento - A Conduta

Avaliar critérios de gravidade/internação.
Solicitar exames laboratoriais se aplicável.
Prescrever conduta medicamentosa exata.

3º Momento - A Vigília

Antecipar e monitorar possíveis complicações. Educar a família para o seguimento.

Cenário 1:

Escolar de 6 anos, sexo masculino, previamente hígido com queixa inicial de “febre alta e manchas pelo corpo há 1 dia”. Mãe refere início há 3 dias com febre alta (até 39,5C), odinofagia intensa e prostração, com evolução para inapetência e dor abdominal leve. Há 24 horas surgiram “manchinhas vermelhas” no tronco que se espalharam para membros. Refere que a pele está áspera ao toque. Sem outras queixas.

Exame físico: FC 120 bpm FR 24 ipm T 38,9C SatO2 98%

Febril, irritado, amígdalas hiperemiadas, aumentadas de volume, presença de exsudato esbranquiçado e petéquias em palato, com língua em aspecto de framboesa. Na pele, presença de exantema micropapular eritematoso difuso, com textura áspera, predomínio em tronco e dobras e palidez perioral. Presença de adenomegalia cervical anterior dolorosa.



Cenário 2:

Introdução: Escolar, 8 anos, sexo feminino, previamente hígida, com queixa de “manchas vermelhas no rosto e no corpo há 2 dias”. Mãe relata que há cerca de 5 dias a criança apresentou mal-estar leve, coriza discreta e febre baixa (máx 37,8C), com melhora espontânea em 2 dias. Há 48 horas surgiu vermelhidão intensa nas bochechas, sendo no dia seguinte, aparecimento de manchas avermelhadas nos braços e pernas, formando desenhos rendilhados. Refere leve prurido, sem dor. Sem outras queixas.

Exame físico: FC 92 bpm FR 20 ipm T 36,8C SatO2 99%

Bom estado geral, ativa, com eritema malar bilateral intenso, palidez perioral, exantema maculopapular rendilhado em membros superiores e inferiores, sem descamação com palmas e plantas poupadas. Sem outras alterações em demais sistemas.



Prontuário Eletrônico: Paciente 01



Escolar, 6 anos, Sexo Masculino.
Previamente hígido.

[FC: 120 bpm]



[FR: 24 ipm]



[T: 38.9°C]



[SatO2: 98%]



Timeline de Sintomas



- **Há 3 dias:** Febre alta, odinofagia intensa, prostração, dor abdominal leve.
- **Há 1 dia:** Surgimento de manchas vermelhas no tronco espalhando para membros. Pele áspera.

Exame Físico

Irritado. **Amígdalas** hiperemiadas/aumentadas com exsudato e petéquias em palato. **Língua em framboesa**. **Exantema micropapular** áspero. **Palidez perioral**. Adenomegalia cervical anterior dolorosa.

| PACIENTE 02 - CENÁRIO DE SIMULAÇÃO

Prontuário Eletrônico: Paciente 02



Escolar, 8 anos, Sexo Feminino.
Previamente hígida.

[FC: 92 bpm]



[FR: 20 ipm]



[T: 36.8°C]



[SatO2: 99%]



Timeline de Sintomas

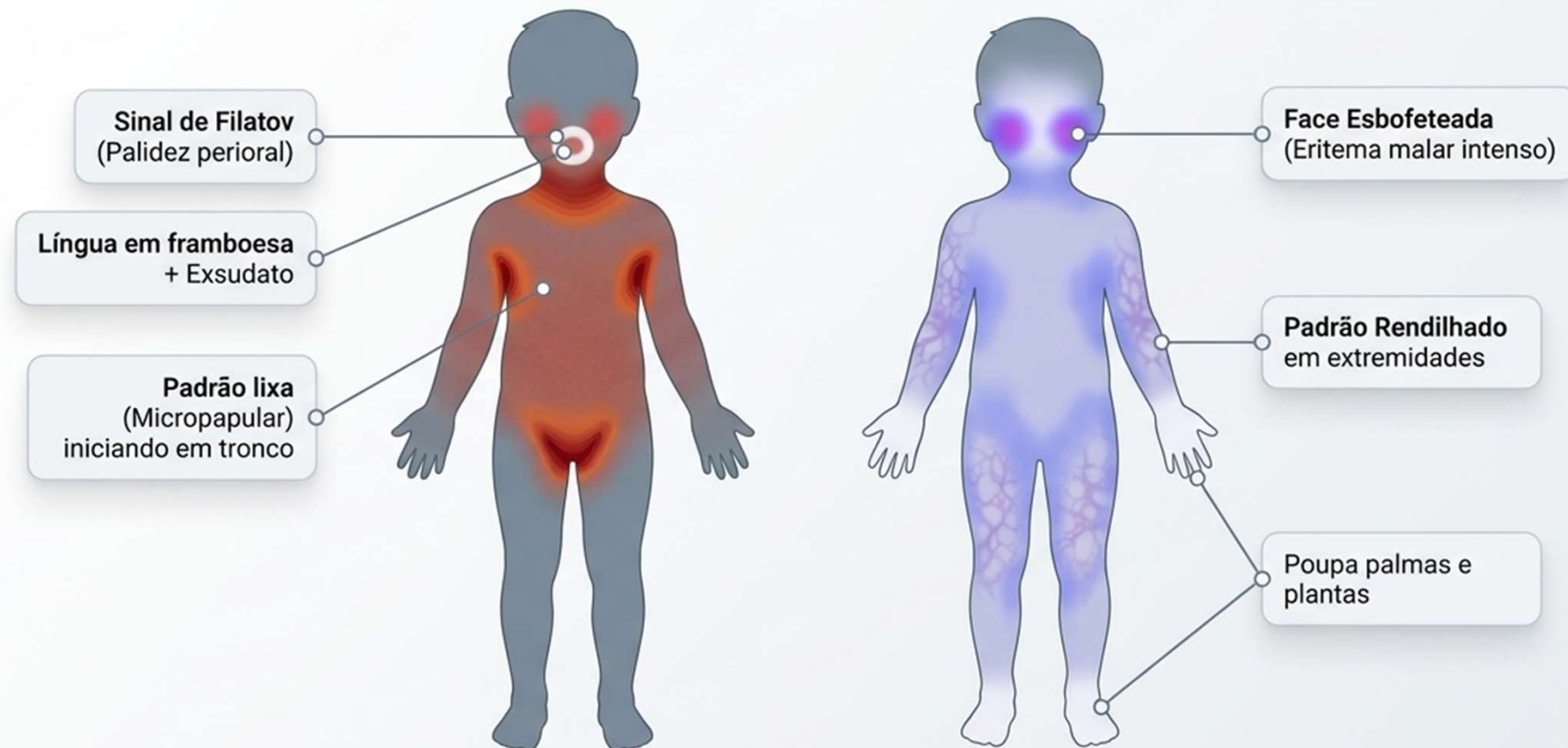


- **Há 5 dias:** Mal-estar leve, coriza discreta, febre baixa (máx 37.8°C) com melhora em 2 dias.
- **Há 2 dias:** Vermelhidão intensa nas bochechas.
- **Hoje:** Manchas avermelhadas em braços e pernas. Prurido leve, sem dor.

Exame Físico

Bom estado geral, ativa. Eritema malar bilateral intenso. Palidez perioral. Exantema maculopapular rendilhado em membros, poupando palmas e plantas. Sem outras alterações.

Mapeamento Anatômico do Exantema



Cinética da Doença: Febre vs. Exantema



Árvore de Raciocínio Clínico

Criança com Febre + Exantema



Toxêmico, febre alta atual, odinofagia.



Textura áspera (lixa), exsudato amigdaliano, língua framboesa.



Diagnóstico: Escarlatina

Antibioticoterapia (Penicilina/Amoxicilina). Rastreamento de complicações (Febre Reumática). Afastamento.

Bom estado geral, febre já resolvida, coriza prévia.



Padrão rendilhado, face esbofeteada, poupa palmas/plantas.



Diagnóstico: Eritema Infeccioso

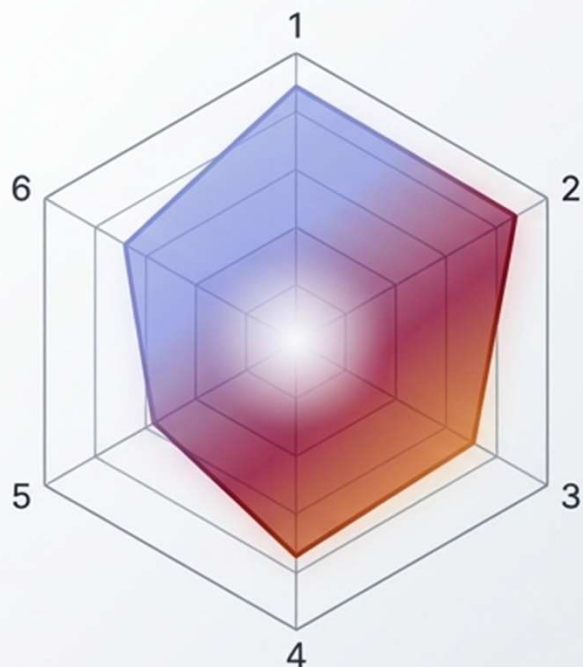
Suporte sintomático (Antitérmicos/Anti-histamínicos). Orientação familiar sobre curso benigno.

Matriz Diagnóstica Diferencial

	Escarlatina	Eritema Infeccioso
Agente	Bactéria (Streptococo beta-hemolítico do grupo A)	Vírus (Parvovírus B19)
Pródromo	Febre alta aguda, odinofagia intensa, prostração.	Subfebril, mal-estar leve, coriza. Resolve antes do exantema.
Exantema	Micropapular eritematoso difuso. Textura de lixa. Predomínio em tronco/dobras.	Maculopapular rendilhado. Poupa palmas e plantas.
Sinais Clássicos	Língua em framboesa, Sinal de Filatov (palidez perioral), Linhas de Pastia.	Face esbofetada (eritema malar intenso).
Conduta	Antibioticoterapia sistêmica + Suporte.	Suporte e observação (autolimitada).

Radar de Avaliação & Debriefing

Métricas de sucesso para o atendimento simulado.



1. Diagnóstico: Diferenciou corretamente as patologias?



2. Etiologia: Identificou os principais agentes causadores?



3. Investigação: Indicou internação e exames corretamente, quando necessários?



4. Terapêutica: Prescreveu a conduta medicamentosa exata para ambas as patologias?



5. Comunicação: Realizou as orientações posteriores de forma clara aos familiares?



6. Documentação: Registrou todas as condutas de forma estruturada no prontuário?

O debriefing estruturado é a chave. Discuta percepções, clareza da liderança e adequação clínica com sua equipe.